

一般妊娠期糖尿病孕妇,在产前饮食控制适当,产后基本不使用胰岛素,其空腹血糖稳定在良好水平。

二、几点体会

1. 妊娠期糖尿病孕妇往往忽略对饮食的控制,在实行营养护理中,需要使病人在思想上相信为她配制的饮食的合理性和制定这一制度的必要性,只要坚持饮食治疗,妊娠期糖尿病即可获得良好的疗效。

2. 妊娠期糖尿病孕妇剖宫产前后的营养护理,必须和药物治疗相结合,妊娠期糖尿病孕妇不应用口服降糖药,宜用胰岛素控制,术前应控制血糖轻度升高状态 5.5—11.0mmol/L(100—200mg/dl),术后禁食应查尿糖,血糖决定胰岛素的用量。

3. 妊娠期糖尿病孕妇剖宫产前后膳食,不单注意对胰腺的影响,还应考虑对胎儿和对整个机体的影响。

孕期内胎儿能量需要必须得到满足,在饥饿状态下,母体为了胎儿做出一定程度补偿,加速肌肉组织的解体,这样仍导致低血糖,所以在母体和胎儿都需要葡萄糖情况下应维持血糖水平。

人体主要利用葡萄糖作为能源,保证蛋白质贮存,并促进剩余热量以脂肪和糖元形式储藏;剖宫产后,最要注意蛋白质的负平衡,充足的热量有节省蛋白质的作用,在热量摄取不足情况下,摄取的蛋白质即用于产生热量,而不能用于组织修复,结果相当于身体组织蛋白的耗损,所以在保护胰腺情况下,尽可能高热量高蛋白饮食。

4. 妊娠期糖尿病孕妇,一般在剖宫产前饮食控制恰当,一旦结束分娩,胎盘排出及全身内分泌发生改变,胎盘绒毛的合体细胞释放的胎盘生乳素(HPL),及其它抗胰岛素作用减少一般不再需要胰岛素治疗,坚持饮食控制,就能巩固疗效。

喹诺酮类药物的临床应用及其药物相互作用

大连医科大学附属第一医院(116011) 刘国华

喹诺酮类药物是近 20 年迅速发展起来的新型抗菌药。尤其是氟喹诺酮类,如诺氟沙星(氟哌酸),环丙沙星(环丙氟哌酸),氧氟沙星(氟嗟酸),依诺沙星(氟啉酸)和培氟沙星(甲氟哌酸)等,更表现其抗菌活性强,抗菌谱广,口服吸收良好,易透过细胞外膜,以及毒性低微和半衰期长等优点。现仅就其临床应用与药物相互作用简述如下。

一、临床应用

1. 泌尿系感染。本类药物治疗膀胱炎,肾盂肾炎和细菌性前列腺炎等泌尿系感染,高度有效。是目前理想的首选治疗药物。其中以环丙沙星抗菌活性最强,总有效率为 94%,氧氟沙星为 93%,诺氟沙星为 83%。

2. 治疗对青霉素敏感或耐药菌株引起的单纯性淋病有很好效果^[1]。

3. 肠道感染。本类药物对沙门氏菌,志贺氏菌及弯曲杆菌有较强的抗菌活性。对治疗由该类细菌引起的肠道感染有效率可达 90.5—100%。其中以诺氟沙星和环丙沙星为优。

4. 骨髓炎。本类药物在骨组织中有很好的分布容积和生物利用度。对由革兰氏阴性菌引起的慢性骨髓炎有很好疗效。

5. 呼吸道感染。喹诺酮类抗菌药能很好的渗入

呼吸道组织和分泌液中。对肺炎、急慢性支气管炎等临床总治愈率,可达 78.5%。

此外,对胆道感染,软组织感染,以及败血症等,亦都有较好疗效。

二、药物相互作用

1. 喹诺酮类药物与抗酸药。本类药物与含有铝、镁、抗酸药同服,可使环丙沙星、依诺沙星、诺氟沙星和培氟沙星(氧氟沙星除外)的血药浓度降至治疗浓度以下。据报道^[2],上述药物与含铝、镁抗酸药合用,其血药浓度可降低 50—98%。机理是,喹诺酮类药物结构上的某些功能因与铝、镁离子在肠道中形成不溶性螯合物,使其吸收减少,杀菌活性减弱。因此,应避免同服或用氧氟沙星替代。

2. 喹诺酮类药物与铁剂。铁剂可减少环丙沙星、氧氟沙星和诺氟沙星在肠道内的吸收。这可能是其与铁形成复合物,而致此类药物的抗菌活性下降^[3]。

3. 喹诺酮类药物与利福平。利福平系肝药酶诱导剂。可通过酶诱导作用使环丙沙星代谢加速,血药浓度下降^[4]。

4. 喹诺酮类药物与锌。据报道^[5],含锌的多种维生素制剂,可使环丙沙星的吸收下降 24%。这可能是锌与喹诺酮类药物形成一种难溶性螯合物所致。

5. 喹诺酮类药物与茶碱。喹诺酮类药物可抑制

细胞色素氧化酶系统,使茶碱代谢减慢,清除率下降,血药浓度升高。如合用,应监测茶碱浓度,调整其剂量。

6. 喹诺酮类药物与山地明(环孢霉素 A)。此类药物与山地明并用,报道不一。有报道,两药并用,山地明血药浓度升高,但无血清肌酐值升高和肾毒性。另有报道,两药并用,可令血清肌酐值升高,可出现急性肾功衰竭,而山地明血药浓度却无变化。为此,对器官移植的病人,并用上述两种药物应慎重。并应监测血药浓度^[6]。

7. 喹诺酮类药物与华法林。喹诺酮类药物与华法林合用,可使后者清除率下降,凝血酶元时间延长。机理是,喹诺酮类药物与血清蛋白结合率高,可将华法林从其结合部位上置换下来^[7],两药并用,有抗凝过度之危险。应监测华法林血药浓度,并调整其剂量。

8. 喹诺酮类药物与丙磺舒。两药并用时,丙磺舒可使喹诺酮类药物的肾率下降,从而使其血药浓度升高,作用增强^[8]。

9. 喹诺酮类药物与呋喃妥因。文献指出,^[9]呋喃妥因可抑制喹诺酮类药物的抗菌活性,在治疗泌尿系感染时,两药应避免合用。

10. 喹诺酮类药物与抗胆碱药。抗胆碱药—东莨菪碱、哌仑西平等,可延缓胃排空,从而延缓喹诺酮类药物的吸收。

11. 喹诺酮类药物与苯妥英钠。喹诺酮类药物可

• 来稿摘登 •

使苯妥英钠代谢减慢,毒性增加,应避免合用。

12. 喹诺酮类药物与组胺 H₂ 受体拮抗剂。西米替丁可延缓培氟沙星的排泄。文献指出^[10],两药合用,培氟沙星的 AUC 约升高 40%,半衰期延长,清除率下降,而雷尼替丁可减少依诺沙星吸收,使其疗效下降,两药合用时,应予监测。

参考文献

1. 姜素椿,等译. 喹诺酮类抗微生物药. 人民军医出版社,1991.
2. 陈世铭. 药物不良相互作用的临床意义与处理. 中国科学技术出版社,1993,641.
3. 管剑龙. 氟喹诺酮类抗菌药与其它药物的相互作用. 国外医学抗生素分册. 1991,12(3)237.
4. 邓万俊. 中国医院药学杂志. 1993. 13(10)449.
5. 陈世铭. 药物不良相互作用的临床意义与处理. 中国科学技术出版社,1993,641.
6. Cook M. c et al ASHP Annual Meeting 1992. 27. P2691.
7. 姜慕炎等. 药物不良相互作用手册. 中国医药科技出版社,1991. 114
8. 陈世铭. 药物不良相互作用的临床意义与处理. 中国科学技术出版社,1993,641.
9. 姜慕炎等. 药物不良相互作用手册. 中国医药科技出版社,1991. 114
10. 管剑龙. 氟喹诺酮类抗菌药与其它药物的相互作用. 国外医学抗生素分册. 1991,12(3)642.

肝动脉插管化疗保持导管通畅的体会

江苏省常熟市第六人民医院(215500) 杨凌云

我院自 1990 年 8 月至 1993 年 11 月对经剖腹证实的 12 例不能切除的肝癌患者,术中做肝动脉和/或门静脉插管,术后局部灌注化疗药物,延长了病人的生存期。

本组 12 例中,男 8 例,女 4 例,年龄 41~68 岁,原发性肝癌 8 例,转移性肝癌 4 例(其中胃癌肝转移 2 例,结肠癌肝转移 1 例,胰体尾部癌肝转移 1 例),该 4 例均做原发病灶的切除。我们选择的导管为 1.5 毫米口径的硅塑管。本组 12 例患者 10 例是采用导管体外封管,2 例是连接皮下埋藏输液器。

我们的体会是,保持导管通畅是至关重要的。导致导管阻塞的原因有:导管扭曲,血块和组织异物

等,一旦阻塞后,输液器导管将失去作用。在放置导管时必须用稀释的肝素溶液反复冲洗,观察有无阻塞、不畅或渗漏,放置后所留导管不要过长,以防止扭曲,关腹前应再用肝素溶液冲洗。术后每次注药后一定要冲洗干净,冲洗时发现阻力可先适当改变病人体位或稍加压力不断冲洗、抽吸,忌冲洗过度用力,以免出现渗漏现象,影响使用。如在化疗间歇阶段亦应每 2 周定期用肝素溶液冲洗,以防阻塞。我们曾遇 2 例间歇时间达 2 个月,结果导管完全阻塞而失去作用。局部灌注化疗药物后病人的胃纳情况影响不大,胃肠道副作用及白细胞的影响均比全身化疗者轻。